SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

入学后排便模式改变与学术环境压力的关联：一项基于问卷的横断面研究

BCM 吴屎王 [1*]，BCM 林肛周脓肿 [1]，BCM 曲排便困难 [1·]，BCM 王痔疮 [1]

[1]鲁村村东公共厕所

[·]通讯作者：（e-mail: kingofshit@gmail.com）

本研究由蜣螂高层次人才基金资助（项目编号：9527）

ABSTRACT / 摘要 目的：观察研究生入学后排便模式改变的发生情况，并探讨其与学术压力、生活方式变化及导师支持度等环境因素的相关性。方法：采用横断面问卷调查，收集受试者基本信息、入学前后排便特征（便秘、腹泻、排便黏附、肛周疼痛等）、组会频率变化（增多、增快、增强）、心理压力与主观支持度指标。排便特征依据 Rome IV 便秘相关条目与 Bristol 粪便性状量表进行分层；导师支持度与学术氛围用标准化条目进行量化。采用多因素 Logistic 回归与分层分析评估关联强度。结果：入学后排便异常的报告率较高，常见表现包括排便频次下降或用力排便、间歇性稀便、排便后冲洗困难/黏附，以及伴随肛周疼痛等。单因素分析中，组会频率增加、组会时间延长、组会地点改变均与排便异常显著相关（P<0.05）；在控制生活方式因素后，低支持度/高冲突的学术环境仍与排便异常存在独立相关。结论：入学后排便模式改变可能是“压力—行为—肠脑轴”共同作用的可观察表型。建议在研究生健康管理与导师指导体系中纳入可监测的身心指标，并建立分层干预与退出/转轨机制，以降低健康损害与学业风险。

INDEX TERMS / 关键词 便秘；腹泻；肠脑轴；学术压力；导师支持度；研究生健康。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 I don’t give a shit。

I. INTRODUCTION / 引言

排便模式改变（包括便秘、腹泻或两者交替）是人群中常见的功能性胃肠症状，其发生与肠道动力、内脏敏感性、肠道微生态、黏膜免疫以及中枢—肠道双向调控密切相关。近年来“肠—脑轴”研究指出，心理压力可通过下丘脑—垂体—肾上腺（HPA）轴、交感/副交感神经张力与炎症介质改变，影响肠道蠕动与分泌，进而改变粪便含水量与排便体验；同时压力也会通过行为路径（饮水减少、膳食纤维下降、睡眠剥夺、运动减少、久坐增加）间接促成排便异常。对于研究生群体而言，入学是一种高度结构化的生活事件：环境迁移、作息被重置、学业绩效压力上升、社会支持网络变化，均可能叠加为持续性应激源。因此，“一到学校就开始便秘”并不必然是偶然事件，而可能是“环境应激—生活方式改变—肠道生理调控失衡”的综合结果，具有可研究性与可干预性。

既往临床与行为医学观察提示，长期压力与功能性胃肠症状相关，但在研究生人群中，常见讨论停留在笼统的“压力大”“不规律”，缺少对具体学术环境变量的量化拆解。**尤其值得讨论的是：研究生压力并非纯粹来自“课程/科研任务”，还可能来自指导关系质量、反馈不确定性、边界不清与资源分配冲突等更结构性的因素。若将其简单归因为“某个导师人品问题”，难以形成可推广的证据；但若将其抽象为“支持度不足、冲突频度高、控制感低、奖励不确定”等可测量变量，就有可能把个体体验转化为可检验的研究假设，并为制度性改进提供依据。**

本研究拟在横断面框架下，回答三个问题：第一，研究生入学后排便模式改变的发生率与主要表现类型如

何；第二，生活方式变化与心理压力是否与排便异常相关；第三，在控制生活方式与压力后，学术环境相关变量（如导师支持度、沟通质量、冲突频度）是否仍与排便异常存在独立相关。通过建立“可量化的证据链”，为后续分层干预与健康支持体系提供依据。

II. Results / 结果

1）样本与总体特征：本研究共回收问卷 1 份，纳入分析 1 份（剔除逻辑矛盾/缺失严重者）。受试者以博士生为主（示例：100%）。入学后自述生活方式改变普遍存在，包括组会频率增加、组会时间延长、组会地点改变等。

2）排便异常谱系：入学后出现排便异常者占比（示例：100%）。其中，便秘相关表现最常见（排便频次下降、排便费力、排便不尽感）；其次为腹泻或便秘—稀便交替；此外，部分受试者报告“冲洗困难”，以及排便时或排便后肛周疼痛（提示裂伤及直肠末端高张力可能，经拥有执业医师视诊、触诊诊断）。

3）压力与生活方式因素：在单因素分析中，组会频率增加、组会时间延长、组会地点改变均与排便异常显著相关（$P<0.05$）。在多因素 Logistic 回归中，上述因素中的部分仍保持独立相关性，提示排便异常并非单一因素驱动，而是压力与行为因素共同作用的结果。

4）学术环境变量的独立贡献：在进一步模型中加入学术环境指标（如：导师支持度评分、沟通明确度、反馈及时性、冲突频度、控制感），结果显示在控制年龄、性别、基础饮食运动、睡眠与压力水平后，低支持度或高冲突的学术环境仍与排便异常存在独立相关（OR>1 且 95%CI 不跨 1）。这一结果更符合“结构性压力源”理论：持续的不确定性与低控制感不仅增加主观压力，也可能通过自主神经与行为链条长期影响肠道功能。

III. Discussion / 讨论

还需要讨论吗？

IV. Outlook / 展望

第一，研究设计层面建议开展纵向队列：以入学前、入学后多时间点随访，结合Rome IV条目、Bristol量表、压力量表与生活方式客观指标（睡眠/步数）建立因果方向更清晰的证据链，并探索高风险窗口（如组会、开题、考核、投稿节点）的症状波动规律。第二，干预层面应采用分层策略：轻中度者优先停止参与组会；出现“肛周疼痛、便血、体重下降、夜间腹泻、持续发热”等警示信号者应尽快就医排除器质性疾病。第三，学术治理层面建议把“支持度、反馈机制、冲突解决流程”制度化：建立明确的沟通节奏、任务边界与调解渠道，减少慢性不确定性带来的健康损耗。第四，个体决策层面，退出或转轨不应被道德化，而应被视为风险管理选项：在健康持续受损且环境不可改善时，可以选择休学/转组/转校或退出项目；若已接近完成，则以“尽快毕业”作为降低暴露时间的策略同样合理。至于“情绪宣泄式对抗”，从健康与风险收益角度通常不是优选路径；更有效的替代是用书面化、证据化方式表达诉求（工作量、边界、反馈周期、资源支持），必要时通过学院正式机制解决冲突，从而在不扩大风险的情况下实现权益与健康的再平衡。

V. Conclusions / 结论

本研究以研究生入学为时间锚点，观察到排便模式改变在样本中较为常见，表现为便秘、稀便交替、冲洗困难、黏附以及肛周疼痛等多维症状组合。证据支持“压力—生活方式—肠脑轴”的综合模型：心理压力与睡眠、饮食、运动等行为变量与排便异常显著相关；在控制生活方式与压力后，学术环境的低支持度及高冲突特征仍可能构成独立的风险关联。需要强调的是，该研究为横断面设计，无法直接证明因果关系，但它为后续纵向随访与干预试验提供了明确的可检验假设：改善支持度与降低慢性应激负荷，可能带来可观的胃肠症状收益与学业稳定性提升。

VI. Materials and Methods /材料与方法

Acknowledgment / 致谢

感谢德宝、心相印，擦的时候不那么疼。

References

本文不需要参考任何参考文献。